



CUIDADO CARIÑOSO
Y SENSIBLE PARA EL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA

Cuidado cariñoso y sensible para todos los recién nacidos



Cuando los y las bebés crecen en un entorno cariñoso y sensible, no solo sobreviven, sino que pueden desarrollarse plenamente. Sin embargo, muchos neonatos se ven privados de su derecho a recibir ese cuidado cariñoso y sensible, incluso durante su estancia en el hospital.

Cada año nacen aproximadamente 140 millones de bebés, de los cuales cerca de 30 millones requieren hospitalización, y entre 8 y 10 millones necesitan cuidados intensivos (1). Desde 1990, la mortalidad neonatal se ha reducido a más de la mitad, pero en 2019 todavía fallecieron unos 2,4 millones de neonatos durante su primer mes de vida (2). Los recién nacidos prematuros, con bajo peso

o con complicaciones en el parto corren más riesgo de morir y de sufrir discapacidad a lo largo de la vida. Si no se invierte en el cuidado cariñoso y sensible, no se podrá seguir reduciendo la mortalidad neonatal.

El nacimiento constituye una transición crítica: el paso de nutrirse dentro del útero a recibir cuidados en el mundo exterior. Es preciso prestar una atención básica al recién nacido, ofreciéndole de inmediato el contacto piel con piel, abrigo, higiene, un inicio temprano de la lactancia materna exclusiva y la presencia constante de los cuidadores («separación cero»). De este modo, se facilita que esta transición sea lo más fluida posible y que el bebé disponga de un entorno afectuoso en sus primeros minutos y horas de vida, lo que permitirá que su cerebro y su cuerpo crezcan y se desarrollen.

¿En qué consiste el cuidado cariñoso y sensible?

Lo que sucede durante la primera infancia (del embarazo hasta los 8 años) sienta las bases para toda la vida. Hemos hecho grandes progresos en la mejora de la supervivencia infantil, pero también tenemos que crear las condiciones adecuadas para ayudar a las niñas y niños a prosperar a medida que crecen y se desarrollan. Esto requiere proporcionar a los niños cuidados cariñosos y sensibles, especialmente en sus primeros años de vida (desde el embarazo hasta los 3 años).

El cuidado cariñoso y sensible comprende cinco componentes interrelacionados e indivisibles: buena salud, nutrición adecuada, seguridad y protección, atención receptiva y oportunidades para el aprendizaje temprano. El cuidado cariñoso y sensible protege a las niñas y niños de los peores efectos de la adversidad y produce beneficios intergeneracionales y de por vida para la salud, la productividad y la cohesión social.

El cuidado cariñoso y sensible ocurre cuando se aprovecha al máximo cada interacción con la niña o el niño. Cada momento, breve o largo, estructurado o no estructurado, es una oportunidad para garantizar que los niños estén sanos, reciban alimentos nutritivos, se mantengan seguros y aprendan sobre sí mismos, sobre los demás y sobre su mundo. Lo que hacemos importa, pero la forma en que lo hacemos todavía importa más.

Un padre y una madre mantienen contacto piel con piel con un recién nacido. © Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño/Isabel Pinto.

En el presente informe temático se presentan los cinco componentes del cuidado cariñoso y sensible y se explica por qué son esenciales para todos los recién nacidos, ilustrándolo con ejemplos prácticos de iniciativas que establecen y consolidan entornos que son cariñosos y sensibles para los recién nacidos, incluidos los que nacen demasiado pronto, son pequeños o están enfermos.

El primer mes es una oportunidad única en la vida de los niños y niñas para comenzar a desarrollar plenamente su potencial. Los responsables de las políticas y la gestión de la atención de salud, los profesionales de la salud y los progenitores pueden liderar la transformación necesaria para que todos ellos empiecen su vida en las mejores condiciones posibles. En este informe se presentan seis casos que ilustran medidas que se pueden adoptar para crear un entorno cariñoso y sensible que permita a los cuidadores ofrecer esta atención desde los establecimientos de salud y, posteriormente, en sus hogares.

La importancia del cuidado cariñoso y sensible para que los recién nacidos sobrevivan y crezcan

El neurodesarrollo empieza durante el embarazo y se acelera rápidamente tras el nacimiento.

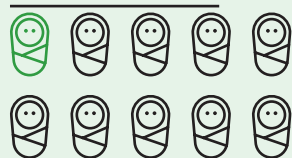
Al término de las 28 semanas de gestación, el feto empieza a oír y, desde que nace, el bebé puede reconocer la voz de su madre. En los primeros días y semanas de vida se establecen conexiones neuronales en el cerebro a una velocidad asombrosa que crean los circuitos necesarios para desarrollar funciones sensoriales que nos acompañan toda la vida, como oír, ver, hablar y comprender el entorno. Para que esto ocurra, el cerebro necesita recibir estímulos adecuados desde el nacimiento, gracias a la interacción cercana con los cuidadores y con el entorno. Cuando los progenitores y otros cuidadores ofrecen cariño al lactante, le brindan la oportunidad de sobrevivir y crecer

Datos y cifras

Más del

80%

de los partos tienen lugar en un establecimiento de salud y son atendidos por un profesional cualificado (4).



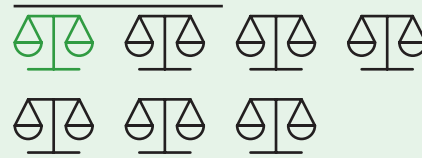
Uno de cada diez bebés nace prematuramente (5).

La prematuridad, las complicaciones del parto, la septicemia neonatal y las anomalías congénitas son causas directas de muerte.

Según los cálculos, cada año mueren

2.4 million

de recién nacidos, en su mayoría por causas que se pueden prevenir (2).



Uno de cada siete bebés nace con bajo peso (6).

El bajo peso al nacer ocasiona entre el 60 % y el 80 % de la mortalidad neonatal (7).

sano, ya sea en un establecimiento de salud o en el hogar. Sin embargo, si se le priva de ese cuidado —por ejemplo, por la separación de sus cuidadores o la exposición al estrés o al dolor—, el lactante se vuelve más vulnerable y corre más riesgo de morir o de sufrir discapacidades que pueden manifestarse en forma de dificultades de aprendizaje, de visión o de audición. Por consiguiente, todos los recién nacidos necesitan recibir un cuidado cariñoso y sensible (1).

Con ese fin, durante el embarazo se requieren al menos ocho visitas prenatales con profesionales de la salud, en las que estos ofrezcan asesoramiento a la madre y a su familia sobre alimentación saludable, prevención del consumo de tabaco y otras sustancias, planificación del parto, promoción de la lactancia y apoyo a la salud mental. Para que la atención prenatal sea óptima, debe comprender la administración de suplementos de hierro y ácido fólico, la realización temprana de una ecografía —si está disponible— para determinar la edad gestacional, y la detección y el manejo precoces de los factores de riesgo de parto prematuro, incluidas las infecciones (8).

Durante el parto también debe prestarse una atención óptima para que la madre esté en condiciones de brindar un cuidado cariñoso y sensible al niño. Debe tener con ella a un acompañante de su elección, y no se le deben practicar procedimientos que no sean necesarios, incluido la cesárea. Los datos muestran que las experiencias traumáticas durante el parto pueden afectar la capacidad de la madre para establecer un vínculo con el bebé y aumentar el riesgo de depresión perinatal. Un aspecto fundamental del apoyo al cuidado cariñoso y sensible consiste en procurar que todas las embarazadas tengan una experiencia positiva del parto, lo cual es más probable cuando la atiende personal de partería (9).



Una madre mira a su bebé mientras duerme en Bangladesh. © USAID/Amy Cotter.

En el primer mes de vida, todos los recién nacidos necesitan apoyo en los cinco componentes del cuidado cariñoso y sensible.

La buena salud del recién nacido exige prevenir y tratar las enfermedades, prestando una atención de alta calidad basada en pruebas científicas a los neonatos pequeños o enfermos.

La nutrición adecuada se consigue optimizando la lactancia materna exclusiva o la alimentación con leche materna, incluso en el caso de los bebés muy pequeños o enfermos.

Ofrecer seguridad y protección significa mantener el calor corporal, garantizar una buena higiene, reducir el estrés y permitir que el cuidador principal —por lo general la madre— permanezca con el lactante en un entorno tranquilo.

El aprendizaje temprano consiste en estimular de forma cuidadosa el cerebro del bebé mediante el tacto, la voz o el simple contacto cercano.

La atención receptiva se practica prestando atención a las señales que emite el bebé, que pueden indicar que está preparado para alimentarse, que siente dolor o que está estresado, y respondiendo adecuadamente a ellas.



¿Cuáles son los componentes del cuidado cariñoso y sensible?

BUENA SALUD



Concierne a la salud y el bienestar de las niñas y niños y sus cuidadores. ¿Por qué ambas cosas? Sabemos que la salud física y mental de los cuidadores puede afectar su capacidad para cuidar a la niña o niño.

NUTRICIÓN ADECUADA



Concierne a la nutrición de la madre y la niña o niño. ¿Por qué ambas cosas? Sabemos que el estado nutricional de la madre durante el embarazo afecta a su salud y bienestar y a los del bebé por nacer. Después del parto, el estado nutricional de la madre afecta su capacidad para amamantar y proporcionar un cuidado adecuado.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



Se refiere a la disponibilidad de entornos seguros y protegidos para las niñas y niños y sus familias. Incluyen los peligros físicos, el estrés emocional, los riesgos ambientales (por ejemplo, la contaminación) y el acceso a alimentos y agua.

OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE TEMPRANO



Hace referencia a todas las oportunidades para que el bebé o la niña o niño pequeño interactúen con una persona, lugar u objeto en su entorno. Reconoce que cada interacción (positiva o negativa, o falta de interacción) está contribuyendo al desarrollo del cerebro la niña o niño y sentando las bases para su aprendizaje posterior.

ATENCIÓN RECEPTIVA



Concierne a la capacidad del cuidador para percibir y entender las señales de su hijo y para darles respuesta de manera oportuna y apropiada. Se considera el componente fundamental porque los cuidadores receptivos tienen mayor disposición a apoyar los otros cuatro componentes.

Establecimiento de un entorno cariñoso y sensible para todos los recién nacidos

Cuando los profesionales de la salud colaboran con las familias para proporcionar un cuidado cariñoso y sensible, aumenta el número de recién nacidos que sobreviven y reciben mejor atención tanto en los establecimientos de salud como en el hogar, lo que les permite desarrollarse plenamente.

Para brindar un entorno cariñoso y sensible, los servicios de atención materna y neonatal deben organizarse en torno a principios fundamentales como la dignidad y el respeto, el intercambio de información, la participación y la colaboración.

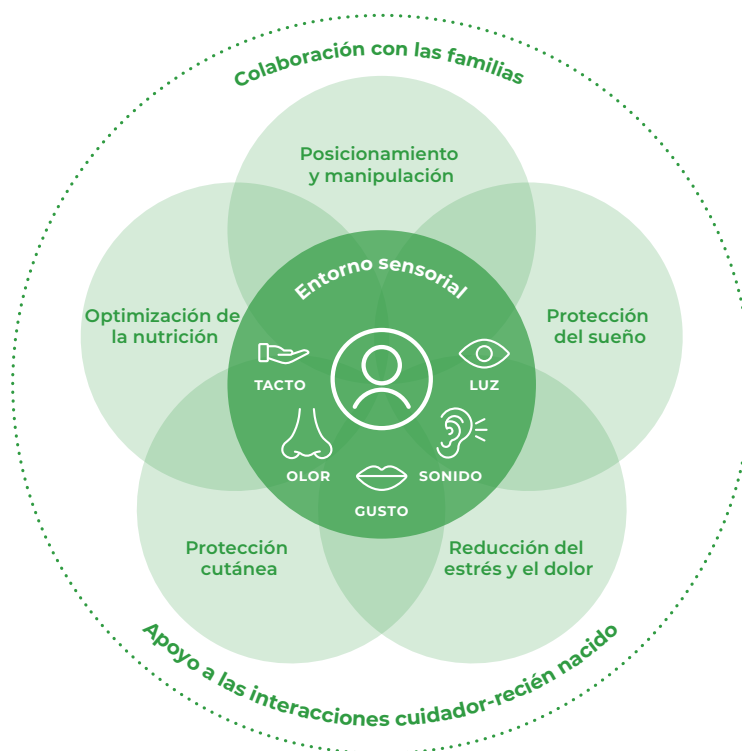
Un enfoque posible es la atención al desarrollo centrada en el lactante y la familia, que crea un entorno cariñoso y sensible para responder a las necesidades de cada bebé y para reducir el riesgo de que sufra daños (véase la figura 1). Esta estrategia reduce el estrés del bebé y de los progenitores, refuerza el vínculo afectivo, favorece la alimentación y el crecimiento del niño, apoya su neurodesarrollo, ayuda a prevenir discapacidades y facilita el alta hospitalaria temprana.

Los elementos del cuidado neonatal que contribuyen al desarrollo son la optimización de la nutrición, el posicionamiento y la manipulación, la protección del sueño, la reducción del estrés y del dolor, y la protección cutánea (9). Este enfoque proporciona un entorno sensorial adaptado a las necesidades de cada lactante y reduce el riesgo de que sufra daños; además, es especialmente importante para los bebés pequeños o enfermos que necesitan ser hospitalizados.

Proporcionar atención esencial desde el nacimiento

La atención al bebé comienza en los primeros segundos, minutos y horas después del parto, e incluye el mantenimiento de la temperatura, el contacto piel con piel inmediato con la madre, la presencia constante de esta (incluso tras una cesárea), la detección temprana de los recién nacidos pequeños o enfermos

Figura 1. Componentes del cuidado del desarrollo centrado en el lactante y la familia (9).



que necesitan atención especial, el inicio precoz de la lactancia materna exclusiva o la alimentación con leche materna, la higiene y el lavado de manos, la cura en seco del cordón umbilical, el baño tardío y la vacunación. Los datos indican que las prácticas recomendadas de atención esencial al recién nacido reducen considerablemente el riesgo de mortalidad neonatal y favorecen el neurodesarrollo (10).

Hacer participar al padre en la atención

La participación plena de la familia en la atención del bebé comienza inmediatamente después del parto, con el contacto piel con piel entre la madre y el bebé durante al menos una hora, tanto tras un parto vaginal como después de una cesárea. Este contacto crea un entorno físico y emocional que promueve la estabilidad fisiológica y refuerza el vínculo afectivo. Durante este valioso periodo, muchos bebés comienzan a buscar el pecho materno e inician la lactancia precoz. No obstante, no debe olvidarse que el padre también cuidará del niño en igualdad de condiciones; por ello, se le debe orientar y apoyar, tanto a él como a otros familiares, a fin de que se impliquen en la atención del lactante.

Aplicar los diez pasos hacia una feliz lactancia natural

La iniciativa «Hospital amigo del niño» (11) y los diez pasos hacia una feliz

lactancia natural fomentan un entorno cariñoso y sensible en los servicios de maternidad y proporcionan a los cuidadores la confianza y las competencias necesarias para ofrecer este tipo de atención a sus bebés.

Promover la lactancia materna exclusiva

Es muy importante no infravalorar la necesidad de iniciar tempranamente la lactancia materna exclusiva para que el bebé esté sano y se desarrolle correctamente. La leche materna contiene todos los nutrientes que la mayoría de los bebés necesitan durante los primeros seis meses de vida, incluidos los pequeños o enfermos que puedan requerir alimentación asistida (por ejemplo, con taza o mediante sonda nasogástrica). Además, la lactancia materna protege frente a enfermedades infantiles frecuentes y reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en la infancia y la adolescencia. A pesar de ello, según estimaciones recientes, solo el 42 % de los lactantes se alimentan exclusivamente de leche materna durante los seis primeros meses de vida (4). Cuando los bebés pequeños o enfermos necesitan una alimentación complementaria, se recomienda darles leche humana donada procedente de bancos de leche seguros y asequibles. En algunos casos, estos bancos no existen y será necesario crearlos.

INDIA:

Ampliación nacional del modelo de atención con participación de la familia

En la India se llevó a cabo un ensayo controlado aleatorizado para elaborar y evaluar un modelo de atención centrada en el lactante y la familia un entorno de atención terciaria: la unidad de cuidados intensivos neonatales del Instituto de Ciencias Médicas Atal Bihari Vajpayee y del Hospital Dr. Ram Manohar Lohia, en Nueva Delhi. Se diseñó un recurso audiovisual estructurado y adaptado a la cultura local para que los progenitores acompañantes aprendieran una serie de intervenciones de atención al recién nacido enfermo mientras este estaba hospitalizado, lo que facilitó la labor del personal, mejoró las tasas de lactancia materna y redujo la duración de la estancia sin que aumentaran las infecciones nosocomiales. La viabilidad y la aceptación de este método se demostraron con cuidadores de distintas características culturales, socioeconómicas y demográficas.

En 2014, el Ministerio de Salud puso a prueba este enfoque en establecimientos de salud pública. Tras comprobar que se contaba con los recursos necesarios para aplicar la atención con participación de la familia y que la innovación recibía una buena acogida, se aprobó su ampliación a todo el país. En 2017 se publicaron las directrices operacionales nacionales y un conjunto de materiales didácticos. Se realizó una evaluación de los efectos de esta atención en 69 unidades distritales de atención especial al recién nacido, en la

que se determinó una serie de prácticas positivas. Se comprobó que las unidades disponían de una logística adecuada y se observó una mejora de las competencias del personal, una mayor participación de los padres en el cuidado y un seguimiento más eficaz tras el alta. En cuanto a la atención domiciliaria, se registró un aumento de la práctica del método de la madre canguro y de las tasas de lactancia materna exclusiva, así como más actividades de juego y estimulación y una mejor detección de las señales de peligro y de la búsqueda de atención. En definitiva, se demostró que la atención con participación de la familia permite mejorar la calidad de la atención de los neonatos enfermos en los establecimientos de salud, además de favorecer prácticas familiares y comunitarias que contribuyen a la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño.

Referencias: Sarin E, Maria A. Acceptability of a family-centered newborn care model among providers and receivers of care in a public health setting: a qualitative study from India. BMC Health Services Research. 2019;19(1):184.

Verma A, Maria A, Pandey RM, Hans C, Verma A et al. Family-centered care to complement care of sick newborns: a randomized controlled trial. Indian Pediatrics. 2017;54(6):455-9.



Un bebé responde con una sonrisa al beso cariñoso de su madre en la India.

Promover la atención receptiva y las actividades para el aprendizaje temprano

Cuando los cuidadores sostienen al bebé y establecen contacto visual con él con frecuencia, y cuando le hablan o le cantan con delicadeza, les resulta más fácil observar las señales que emite y reconocer cuándo está preparado para alimentarse o dormir. Aprender a reconocer y comprender esos signos con el apoyo del personal de salud, y responder a ellos, aumenta la confianza de los progenitores y su capacidad para seguir atendiendo las necesidades cambiantes del bebé en el hogar. Este apoyo puede resultar especialmente importante para los padres y madres primerizos.

Velar por la salud mental de los cuidadores

Los progenitores de los recién nacidos pueden sentirse cansados, desbordados o inseguros acerca de la mejor manera de cuidarlos. Es fundamental brindarles apoyo, prestando atención a su salud mental. Un dato revelador es que una de cada seis mujeres presenta síntomas de depresión posparto que afectan a su capacidad para cuidar del bebé (12). Todos los progenitores agradecen que se les pregunte cómo se encuentran y, cuando los profesionales de la salud escuchan con empatía, pueden ofrecerles sugerencias sencillas y útiles ante los problemas emocionales expresados, como centrarse en la relación con el lactante, mantener una alimentación adecuada, dormir lo suficiente, relajarse y realizar actividad física.

Prestar atención posparto tras el alta del establecimiento de salud

Es importante prestar atención durante el primer mes posterior al parto para que la madre y el bebé estén sanos en todos los aspectos: el físico, el nutricional, el mental y el social. Tras un parto vaginal sin complicaciones en un establecimiento de salud, las madres y los bebés sanos deben permanecer en el centro al menos 24 horas. Posteriormente, se recomiendan al menos tres visitas adicionales para todas las madres y niños: al tercer día (entre 48 y 72 horas), entre el séptimo y el decimocuarto día y a las seis semanas del parto (13).

La atención integrada a la madre y el bebé, tanto en el hogar como en el establecimiento de salud, es fundamental y debe incluir la evaluación de los signos de enfermedad en ambos, la

termorregulación, la cura del cordón y la vacunación, así como el apoyo a la lactancia materna exclusiva. Hay dos elementos esenciales de la atención posparto que a veces se descuidan: el asesoramiento sobre atención receptiva, comunicación y juego con el bebé, y la evaluación y el apoyo a la salud mental de la madre. Asimismo, los recién nacidos que hayan sufrido complicaciones o que pertenezcan a familias en situación de vulnerabilidad pueden requerir más visitas de seguimiento.

Cuidado cariñoso y sensible para los recién nacidos pequeños o enfermos

Cada año nacen unos 20 millones de bebés con bajo peso (menos de 2500 g), de los cuales 15 millones son prematuros (5).

Además, se calcula que 6,9 millones de bebés presentan posibles infecciones bacterianas graves o septicemia (14).

La prematuridad y la septicemia ocasionan más de la mitad de las muertes neonatales y, junto con los problemas durante el parto y las anomalías congénitas, son las principales causas de mortalidad neonatal (4).

Cuando un bebé nace demasiado pronto, es demasiado pequeño o está enfermo, se le debe prestar una atención adicional debido a su mayor vulnerabilidad. En condiciones ideales, son los progenitores quienes deben encargarse de procurar estos cuidados, en estrecha colaboración con los profesionales de la salud. Aproximadamente dos tercios de los neonatos pequeños o enfermos no necesitan cuidados intensivos, sino simplemente más apoyo relacionado con la alimentación, el abrigo y la prevención de infecciones, todo ello en un entorno cariñoso y sensible.

Promover la presencia constante de los cuidadores («separación cero»)

En ocasiones, el vínculo entre el bebé y sus progenitores se ve obstaculizado innecesariamente, sobre todo en el caso de los bebés pequeños o enfermos. Los padres y madres separados de sus hijos tienen más probabilidades de sufrir ansiedad y sentir impotencia que los que participan activamente en el

cuidado del bebé. Permanecer junto al niño les permite aprender a atender sus necesidades. La mejor forma de garantizar que los progenitores ofrezcan un cuidado cariñoso y sensible en todo momento es permitirles estar con el niño el tiempo que quieran, alojándolos juntos y ofreciéndoles la oportunidad de practicar el contacto piel con piel.

Prestar una atención hospitalaria que favorezca el desarrollo

El entorno hospitalario influye en el modo en que los neonatos que necesitan permanecer en el centro y sus familiares viven esta experiencia. El bebé responde a los estímulos de sus sentidos mediante cambios fisiológicos en la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno que pueden afectar al desarrollo cerebral. Algunos estímulos —como las luces brillantes, el ruido o los procedimientos dolorosos— pueden resultar demasiado intensos y afectarle negativamente, mientras que los adecuados para su estado y la etapa de su desarrollo —como masajearlo suavemente, hablarle o cantarle en voz baja y mantener el contacto piel con piel— producen efectos positivos en sus constantes vitales y favorecen el contacto visual y los movimientos controlados de las extremidades.

La iniciativa «Hospital amigo del niño» se ha adaptado para atender a los bebés pequeños o enfermos (15), de modo que se ajuste a las pautas del enfoque de atención al desarrollo centrada en el lactante y la familia (véase la figura 2). Este enfoque promueve la participación directa de los progenitores en la atención habitual y la práctica frecuente del contacto piel con piel o del método de la madre canguro, además de favorecer la lactancia materna exclusiva o la alimentación con leche materna.

Asimismo, la atención al desarrollo centrada en el lactante y su familia reduce los estímulos negativos causados por el ruido y las luces intensas, agrupa los procedimientos médicos en momentos puntuales y respeta los ciclos de sueño del bebé, gracias a la programación de la prestación de la atención y de la alimentación. Además, se permite que la madre esté presente durante las intervenciones, no se aplica presión ni sustancias irritantes sobre la piel del bebé y aplican protocolos sobre el uso de emolientes y de adhesivos que no causen daños. De este modo, las familias brindan al niño una atención adaptada a cada etapa de su desarrollo.

SUECIA:

«Separación cero» entre los bebés pequeños o enfermos y sus cuidadores

En el hospital de referencia de la Universidad de Uppsala, la unidad de cuidados intensivos neonatales aplica de forma estricta el enfoque de atención al desarrollo centrada en el lactante y la familia. Como afirma la enfermera neonatal responsable: «Lo que hagas a menudo, acabarás haciéndolo bien». Tras los partos vaginales y por cesárea, e incluso en el caso de los recién nacidos prematuros, se inicia directamente la denominada «separación cero» entre el neonato y la madre mediante el contacto piel con piel en la sala de partos y el apoyo respiratorio.

El personal del hospital ha buscado soluciones prácticas para mantener juntos a la madre y al bebé. Los lactantes que no están muy enfermos son atendidos en la sala de maternidad, pero si necesitan ser trasladados a la unidad de cuidados intensivos neonatales, las familias encuentran en ella un entorno acogedor. Junto a cada cuna hay una cama para la madre o el padre, y se aplican otras medidas para favorecer la convivencia familiar, como la disponibilidad de habitaciones para familiares, la ausencia de restricciones a las visitas de amigos y parientes y la presencia de un hermano o hermana mayor del bebé en la unidad, donde hay zonas de estudio y de juego. Las enfermeras han pasado de cuidar directamente a los bebés a enseñar y prestar apoyo a los progenitores para que sean ellos quienes lo

hagan. Ya no se usa ropa de bebé —que anteriormente constituía un obstáculo importante— a fin de favorecer el mantenimiento del contacto piel con piel. El enfoque de atención al desarrollo centrada en el lactante y la familia se aplica gracias a datos procedentes de estudios y a las prestaciones parentales existentes en Suecia: cuando un niño necesita cuidados intensivos, ambos progenitores pueden dedicarle tiempo y están exentos de trabajar durante su estancia hospitalaria. Además, al dar de alta al niño, los progenitores pueden disfrutar de permisos de maternidad y paternidad.

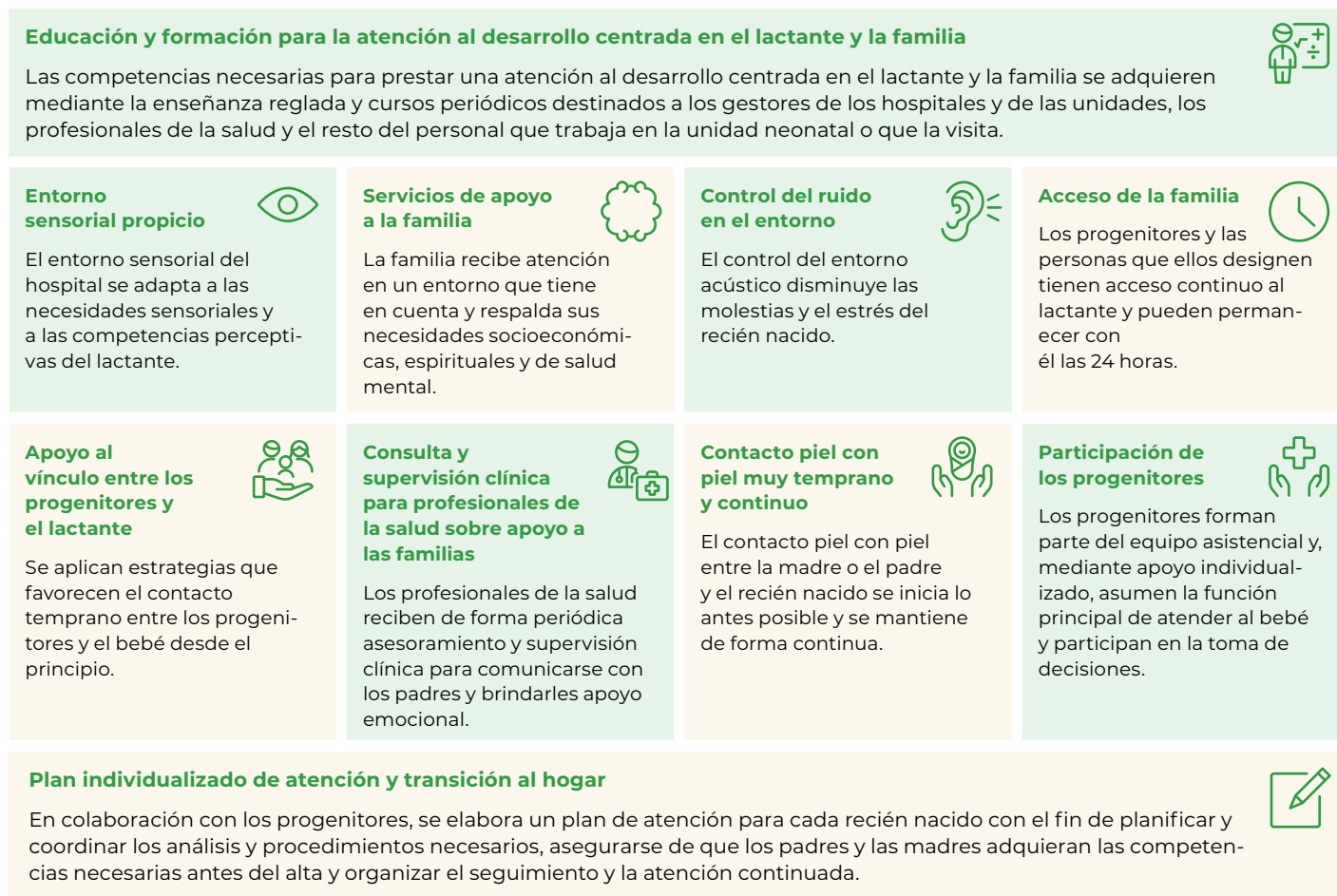
Para que todos los recién nacidos, incluidos los que están en unidades de cuidados intensivos, gocen de su derecho a tener siempre a uno de sus progenitores a su lado, se necesita un apoyo social firme. En enero de 2020, Suecia fue uno de los primeros países del mundo en ir más allá de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño para incorporar plenamente este instrumento en su legislación.

Referencia: Roué J-M, Kuhn P, Maestro ML, Maastrup RA, Mitanchéz D et al. Eight principles for patient-centred and family-centred care for newborns in the neonatal intensive care unit. Arch Dis Child-Fetal and Neonatal Edition. 2017;102(4):F364-8



El hermano mayor en contacto piel con piel con su hermano en Suecia. © Hospital Universitario Karolinska, Estocolmo (Suecia)/Stina Klemming.

Figura 2. Normas de atención al desarrollo centrada en el lactante y la familia



Adaptado de: European Foundation for the Care of Newborn Infants (10).

Apoyo para el método de la madre canguro

El método de la madre canguro es una forma muy eficaz de proporcionar todos los componentes de la atención centrada en el desarrollo a los bebés prematuros y con bajo peso al nacer, incluso cuando están enfermos (16). Consiste en mantener un contacto piel con piel continuo o prolongado del bebé con la madre, el padre u otro cuidador principal; fomentar la lactancia materna exclusiva o la alimentación con leche materna; y facilitar su alta temprana del establecimiento de salud.

Este método ayuda a que los padres tengan una percepción más positiva del lactante pequeño y mejora su capacidad para percibir las señales que emite y responder a ellas, así como su confianza en sus aptitudes para atenderle. De este modo, se ofrece al bebé un ambiente sensorial adecuado mediante la voz de los cuidadores y un tacto y una estimulación suaves. Los bebés sufren menos hipotermia y menos infecciones, tienen una respiración más estable y duermen mejor.

El método de la madre canguro beneficia emocional y económicamente a las familias. Se asocia con una mayor supervivencia y un mejor neurodesarrollo del recién nacido, así como con una disminución del tiempo de hospitalización. Además, reduce la ansiedad y la depresión posparto en los cuidadores. Los beneficios cognitivos, conductuales y sociales para el lactante son duraderos: mayor asistencia escolar, menos conductas antisociales y salarios por hora más altos en el futuro. Estos efectos aumentan cuando el padre participa en la atención y cuanto más tiempo se mantiene el contacto piel con piel.

Este método suele iniciarse en los establecimientos de salud, pero también lo ha aplicado satisfactoriamente personal cualificado fuera de dichos centros. Tras el alta, se puede mantener en el hogar con el apoyo y el seguimiento adecuados. Las unidades de cuidados intensivos neonatales pueden ayudar a la madre a aplicarlo sin riesgos como parte del cuidado centrado en el lactante y la familia (17).

Transformar las unidades de cuidados intensivos neonatales

Es fundamental que los cuidadores se impliquen en la atención habitual a los recién nacidos que requieren cuidados especiales o intensivos. Estos bebés son especialmente vulnerables y sus cerebros y cuerpos inmaduros se benefician de la proximidad y del cuidado afectuoso de la madre, el padre u otros cuidadores. La convivencia del cuidador con el bebé debe convertirse en una práctica habitual, con el objetivo de lograr la separación cero. En Escandinavia ya se ha introducido la atención combinada a la madre y al lactante, es decir, se presta atención de salud a la madre mientras permanece con el bebé en la unidad de cuidados intensivos neonatales (18). Los datos recientes obtenidos en Etiopía, Ghana, India, Malawi y Nigeria demuestran que este enfoque también es viable y muy eficaz en países de ingresos bajos y medianos (17).

Para apoyar a los cuidadores cuando su recién nacido necesita cuidados especiales o intensivos, se les debe animar a centrarse en lo que pueden

aportar, como consuelo, cercanía, estimulación y seguridad emocional. Con el apoyo personalizado del personal de salud, los cuidadores aprenden rápidamente a atender a su bebé pequeño o enfermo, es decir, cambiar pañales, alimentarlo con leche materna, sostenerlo piel con piel y cuidarlo de forma cariñosa y sensible cuando está despierto y activo. Al implicarse de este modo, la confianza de los cuidadores se refuerza y mejora su vínculo afectivo con el bebé. Además, las madres con más experiencia presentes en la unidad también pueden prestar su apoyo.

Facilitar la transición fluida a la atención en el hogar

Cuando los progenitores aprenden y practican el cuidado cariñoso y sensible en el hospital, adquieren las competencias y la confianza necesarias para atender mejor a su bebé en el hogar. Debe elaborarse un plan individualizado de atención y transición al hogar, en colaboración con los progenitores y los profesionales de la atención primaria de salud de la comunidad, en el que se tengan en cuenta la importancia de los análisis y procedimientos de seguimiento necesarios y el momento oportuno para realizarlos. Antes del alta, los progenitores deben sentirse preparados para proporcionar todos los cuidados habituales y continuados que necesite su hijo. Para que la madre no se fatigue en exceso, la familia debe prestarle apoyo y debe haber otros cuidadores que se impliquen en la preparación para la atención en el hogar.

Reforzar el sistema de salud

Crear un entorno propicio para la atención hospitalaria que favorezca el desarrollo

A fin de prestar una atención que favorezca el desarrollo del bebé se necesitan camas, sillas, agua, baños, comida o espacios para cocinar y servicios de lavandería destinados a las familias para que las madres, los padres u otros cuidadores de la familia permanezcan con el niño. También se necesitan lugares para extraer y almacenar de forma inocua la leche materna, utensilios

y apoyo para la alimentación con taza y leche humana donada cuando sea viable y adecuado. En muchos establecimientos se deberán reorganizar los espacios de la unidad como parte de un compromiso renovado de cumplir los requisitos del cuidado cariñoso y sensible.

Invertir en el personal de salud

Incluso cuando tengan carencias en el personal de salud, los países pueden adoptar medidas para consolidar los recursos humanos dedicados a la salud neonatal. Es necesario invertir en equipos estables de profesionales de medicina, enfermería y otras disciplinas afines para crear un entorno favorable. En las unidades de cuidados especiales e intensivos, los equipos deben contar con personal que disponga de competencias especializadas en neonatología y un buen conocimiento de las necesidades fisiológicas, psicosociales, emocionales y espirituales de los recién nacidos y sus familias. Para lograr una buena colaboración entre los progenitores y el personal de salud debe establecerse una comunicación respetuosa, con escucha activa, y una toma de decisiones compartida, de manera que los progenitores se sientan con confianza para ser los cuidadores principales. Asimismo, deben ofrecerse a los profesionales de la salud sistemas de apoyo eficaces y un lugar de trabajo propicio y saludable, con supervisión adecuada y tiempo suficiente para que estén motivados a fin de prestar una atención centrada en el desarrollo que incluya el apoyo emocional.

Velar por un seguimiento adecuado

Cuando finalizan los cuidados especiales o intensivos, es fundamental mantener la vigilancia del crecimiento y el desarrollo de los lactantes con mayor riesgo y someterlos a pruebas de tamizaje de determinadas afecciones, como los problemas de visión y audición. Con ese fin, se deben programar las citas correspondientes. También se deben ofrecer a los progenitores acceso a los servicios sociales, permisos remunerados y el apoyo de otros progenitores, de manera que tengan una experiencia positiva, así como la posibilidad de disponer de un profesional de atención

primaria que pueda facilitarles el acceso a la atención pertinente cuando sea necesario. Cuando los trabajadores de salud comunitarios están bien integrados en el sistema de atención primaria, pueden ser fundamentales para prestar apoyo a domicilio. Por otro lado, se ha demostrado que el apoyo que ofrecen otros progenitores permite mejorar la capacidad y la confianza de los cuidadores para atender a su bebé cuando este es vulnerable. Este apoyo puede ofrecerse de forma individual o en grupo, ya sea presencialmente o mediante recursos digitales. Asimismo, hay asociaciones de progenitores que trabajan en pro de la atención a los recién nacidos pequeños o enfermos cuya contribución puede ser de gran ayuda para mejorar la calidad de la atención neonatal y ofrecer recursos útiles a las familias.

Actualizar la cobertura de los servicios esenciales en el marco de la cobertura sanitaria universal

Para aplicar todas las medidas del enfoque de atención centrada en el desarrollo y ampliar el acceso a estos servicios, deben incluirse las intervenciones pertinentes en los conjuntos básicos de prestaciones de la atención primaria y de la cobertura sanitaria universal. De este modo, los proveedores públicos y privados podrán cubrir los costos de la atención tanto al bebé como al cuidador y se evitará que las familias sufran dificultades económicas.



Un padre sonríe mientras sostiene a sus mellizos recién nacidos en contacto piel con piel. © Fundación Canguro, Bogotá (Colombia).

FILIPINAS:

Atención a los bebés pequeños o enfermos en el conjunto de prestaciones del seguro nacional de salud

En el Dr. Jose Fabella Memorial Hospital de Manila, el método de la madre canguro se aplicó por primera vez en 1999, después de que un neonatólogo y una enfermera de la unidad de cuidados intensivos neonatales asistieran a un curso en la Fundación Canguro de Colombia. La implicación de la dirección del hospital fue el primer paso hacia la adopción de una normativa interna para practicar este método con los recién nacidos prematuros o con bajo peso.

Tras la formación inicial se estableció un comité específico en el hospital para supervisar y coordinar la implantación del modelo. A tal efecto: 1) se capacitó a un equipo básico de formadores que impartió un curso al resto del personal de salud y de otras profesiones afines; 2) se ofreció orientación en el puesto de trabajo; 3) se hicieron un seguimiento y una evaluación mediante estudios y auditorías; y 4) se elaboró una política hospitalaria. Además, se firmó un memorando de entendimiento con el Departamento de Salud de la ciudad de Manila para prestar atención posterior al alta a las familias que practicaban el método, merced a la participación comunitaria (2004). Otros centros de salud de la ciudad incorporaron estas mismas medidas y, en 2005, se formalizó la primera red de servicios del método de la madre canguro.

Conscientes de los beneficios de esta práctica para la supervivencia de los recién nacidos pequeños o enfermos, los formadores principales promovieron la creación en 2008 de la Kangaroo Mother Care Foundation de Filipinas. Poco después, se establecieron en todas las regiones del país programas hospitalarios con vínculos comunitarios y se reconoció y habilitó a varios establecimientos como centros de excelencia. La Fundación, que se creó como organización no gubernamental independiente, cuenta desde 2013 con el apoyo de asociaciones profesionales, asociados internacionales para el desarrollo y el Ministerio de Salud. En 2016, el método de la madre canguro se incorporó al conjunto de intervenciones de atención a los bebés pequeños y, en 2017, se incluyó en el conjunto de prestaciones del seguro nacional de salud para los recién nacidos prematuros o pequeños.

Más información en: <http://www.kangaroomothercareph.org>.

ESTUDIO EN VARIOS PAÍSES:

El inicio inmediato del método de la madre canguro salva vidas

En un ensayo aleatorizado realizado en cinco hospitales de Ghana, India, Malawi, Nigeria y la República Unida de Tanzania, el inicio del método de la madre canguro inmediatamente después del parto con neonatos con un peso entre 1,0 y 1,799 kg redujo la mortalidad en un 25%. Estos bebés muy pequeños fueron atendidos en unidades de cuidados intensivos por sus madres, en estrecha coordinación con el personal de salud. Para aplicar modelo de atención conjunta a la madre y el recién nacido es preciso adaptar el entorno hospitalario para que se pueda mantener de forma continua el contacto piel con piel y para que las madres permanezcan con sus bebés mientras son atendidas tras el parto. Anteriormente, otro cuidador principal —por ejemplo, el padre— se encargaba de practicar el contacto piel con piel mientras se atendía a la madre. Basándose en estos resultados, se ha calculado que iniciar el método inmediatamente después del parto, en vez de hacerlo una vez que el bebé está estable, podría salvar la vida a unos 150 000 neonatos adicionales cada año.

Para más información, consúltese la publicación (17).



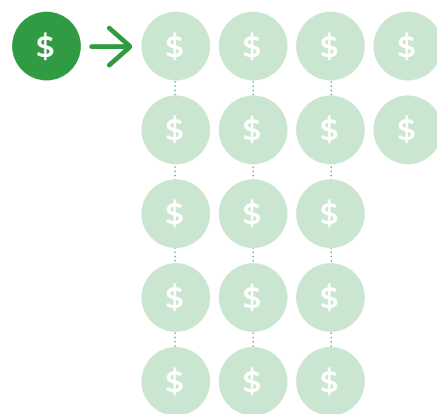
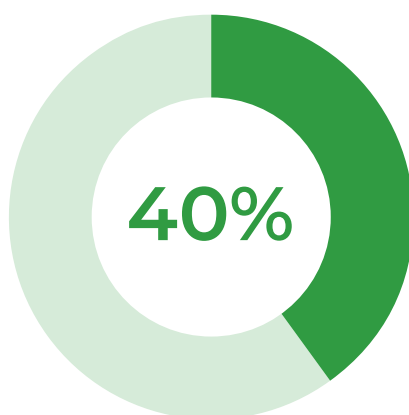
Una enfermera ayuda a una madre a iniciar el contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento. © Fundación Canguro, Bogotá (Colombia).

¿Sabía usted?

Más del

80%

del cerebro humano se forma en los primeros tres años de vida.



El cuidado y el apoyo que el padre, la madre y otros cuidadores brindan a las niñas y niños en sus primeros años es fundamental para el desarrollo saludable del cerebro.

En los países de ingresos bajos y medianos, 250 millones de niñas y niños menores de 5 años –más del 40% de los niños– están más expuestos a no alcanzar su potencial de desarrollo debido a la pobreza y el abandono (20).

Cada US\$1 adicional invertido en el desarrollo de la primera infancia puede producir una rentabilidad de entre US\$6 y US\$17 (21).

0-3

El cerebro humano se desarrolla más rápido desde la concepción hasta los 3 años de vida que en cualquier otro momento.



En los primeros años de vida, los padres, los familiares cercanos y otros cuidadores son los que están más cerca de la niña o niño pequeño y, por tanto, los mejores proveedores de cuidados cariñosos y sensibles. Con el fin de proporcionar a los cuidadores tiempo y recursos para proporcionar cuidados cariñosos y sensibles, deben establecerse políticas, servicios y mecanismos de apoyo a la comunidad.

Cuidar, proteger y apoyar a los cuidadores y las niñas y niños es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



El cuidado cariñoso y sensible mejora la salud, la productividad y la cohesión social a lo largo de la vida, y sus beneficios persisten en la próxima generación.

Innovación para brindar un cuidado cariñoso y sensible en las unidades de cuidados intensivos neonatales

En las unidades de cuidados intensivos neonatales del Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut (Líbano) se está promoviendo una mayor participación de las familias en la atención a los recién nacidos prematuros o enfermos con alto riesgo. En lugar de separarles de sus bebés, las madres y los padres participan en la atención hospitalaria habitual. En esta unidad centrada en la familia se aplican las siguientes medidas:

- Todos los lactantes que necesitan permanecer en una incubadora se colocan en una posición que reproduce la del útero materno.
- El entorno de la unidad es tranquilo, con luz tenue y respeto de periodos de silencio.
- Las madres proporcionan leche materna lo antes posible.
- Se practica la estimulación oral no nutritiva para favorecer que los bebés comiencen a succionar antes.
- Se enseña a las madres y los padres a sostener al bebé suavemente con las manos, como lo harían con los brazos.
- Una vez que los lactantes están estables, las madres y los padres los mantienen en contacto piel con piel tanto como sea posible.
- Las madres y los padres aprenden a ofrecer los cuidados habituales a sus hijos y les hablan o cantan en voz baja.
- Se atiende de forma individualizada a los recién nacidos para favorecer su desarrollo, además de hacer un seguimiento de su desarrollo físico.
- Junto a la unidad hay una sala familiar para que las madres puedan descansar.

La aplicación de este enfoque, que se basa en el Programa Individualizado de Evaluación y Atención para el Desarrollo del Recién Nacido, ha aumentado la implicación de los progenitores y el vínculo afectivo con sus hijos, y además se ha mejorado su capacidad para responder a las señales sutiles de los lactantes más débiles. El personal de enfermería y medicina mantiene una actitud positiva y facilita la transición hacia un modelo de atención centrado en la familia. Los profesionales de la unidad están evaluando los resultados de este método en el desarrollo de los niños y prevén que aquellos cuyos padres participan activamente en la atención y la estimulación tempranas presenten menos retraso del desarrollo que los que son atendidos en unidades convencionales orientadas a las tareas.

Referencias: Als H, McNulty GB. The newborn individualized developmental care and assessment program (NIDCAP) with kangaroo mother care (KMC): comprehensive care for preterm infants. *Current Women's Health Reviews*. 2011; 7(3):288-301.

Charafeddine L, Masri S, Sharafeddin SF, Kurdahi Badr L. Implementing NIDCAP training in a low-middle-income country: comparing nurses and physicians' attitudes. *Early Hum Dev*. 2020;147:105092.



COLOMBIA:

Mantenimiento del método de la madre canguro durante la pandemia de COVID-19

Desde 1994, la Fundación Canguro de Bogotá (Colombia) practica el método de la madre canguro como alternativa de atención neonatal basada en la evidencia. Tras la confirmación del primer caso de COVID-19, el Gobierno impuso diversas restricciones y declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional. Aunque el personal de medicina y enfermería de la Universidad Javeriana que trabaja con el programa que aplica este método no era ajeno a las posibles consecuencias del virus, seguía convencido de que era la mejor manera de atender a los recién nacidos prematuros o con bajo peso.

Poco después del inicio de la pandemia, la Asociación Colombiana de Neonatología, el Ministerio de Salud de Colombia y la Fundación Canguro publicaron la primera guía sobre la seguridad y la continuidad de los Programas Madre Canguro, que incluía medidas de bioseguridad para cuidadores y personal de salud, el manejo de madres sintomáticas y asintomáticas y la organización de las consultas ambulatorias.

A diferencia de lo ocurrido en otros países, donde las directrices oficiales exigían separar a las madres con infección por COVID-19 confirmada o presunta de sus recién nacidos, la colaboración estrecha entre estas instituciones permitió mantener el alojamiento

conjunto. Como resultado de ello, 50 indicadores de salud maternoinfantil se mantuvieron en los niveles previos a la pandemia, al tiempo que aumentó la lactancia materna, posiblemente porque los progenitores comprendieron mejor que su participación era esencial para el desarrollo del sistema inmunitario del niño.

El personal continuó promoviendo la lactancia materna y desaconsejando la separación entre madre e hijo, consciente de las grandes ventajas que ofrece tanto para la madre como para el bebé, incluso en los casos de positividad para la COVID-19. En el estudio de caso completo puede consultarse información detallada sobre las medidas adoptadas para mantener el método de la madre canguro durante la pandemia de COVID-19.

Referencia: Hackett K, Proulx K, Alvarez A, Whiteside P, Omoeva C. Case studies of programs to promote and protect nurturing care during the COVID-19 pandemic. FHI360, The LEGO Foundation; 2021 (<https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-lego-case-study-nurturing-care-report.pdf>, consultado el 21 de abril de 2021).



Un bebé mira con curiosidad a una enfermera en Côte d'Ivoire. © UNICEF/UNI312809/Dejongh.

Conclusion

Las primeras horas, días y semanas posteriores al parto constituyen un periodo crucial para la supervivencia, la salud y el desarrollo del recién nacido. Existen conocimientos e instrumentos que permiten ofrecer a todos los bebés un cuidado cariñoso y sensible en el que participen directamente los progenitores y otros cuidadores. Para establecer las condiciones necesarias que permitan brindar esta atención, es fundamental invertir en políticas, sistemas de salud y sensibilización comunitaria. Hemos logrado aumentar el número de recién nacidos que sobreviven, y ahora debemos velar por que crezcan sanos y se desarrollen plenamente. Esto es especialmente importante en el caso de los niños que corren más riesgo, como los que son pequeños y los que están enfermos, ya que son más propensos a padecer afecciones graves y a fallecer.

La pandemia de COVID-19 ha alterado profundamente la vida de las familias y las comunidades, pero los sistemas de salud se han esforzado por mantener los servicios esenciales. No se han encontrado indicios de virus infecciosos capaces de replicarse, infectar otras células y transmitirse a través de la leche materna (22). La iniciativa colombiana demuestra que se pueden seguir aplicando las prácticas descritas en el presente informe a pesar de la COVID-19 para continuar ofreciendo a los recién nacidos un cuidado cariñoso y sensible, siempre que se sigan las medidas de protección adecuadas.

Existen normas de atención (3, 10) que fundamentan las medidas que deben adoptar los responsables de las políticas, los gestores de los programas de salud y otras partes interesadas. Se están definiendo indicadores básicos para medir los avances en la calidad de la atención neonatal, incluso para los recién nacidos pequeños o enfermos. Ya es hora de que se atienda a todos los recién nacidos prestándoles un cuidado cariñoso y sensible.

Recordar

El primer mes de vida es un periodo crítico para el crecimiento y el desarrollo saludables de los niños.

Fortalecer

Es fundamental mejorar la calidad de la atención que reciben las madres y los recién nacidos en los servicios de maternidad y de cuidados neonatales, conforme a normas bien definidas.

Añadir

Es posible brindar un cuidado cariñoso y sensible a los recién nacidos pequeños o enfermos que necesitan cuidados especiales o intensivos mediante la atención centrada en el desarrollo del lactante y la familia, incluso en los países de ingresos bajos y medianos.

AGRADECIMIENTOS

EQUIPO DE REDACCIÓN:

Bernadette Daelmans (Departamento de Salud de la Madre, el Recién Nacido, el Niño y el Adolescente, y Envejecimiento [MCA] de la Organización Mundial de la Salud [OMS]), Louise Tina Day (Facultad de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres) y Ornella Lincetto (OMS/MCA).

Las autoras desean expresar su agradecimiento a Nathalie Charpak (Fundación Canguro, Bogotá, Colombia), Arti Maria (ABVIMS & Dr Ram Manohar Lohia Hospital, Nueva Delhi, India), Lama Charafeddine (Universidad Americana de Beirut, Departamento de Pediatría y Medicina del Adolescente, Beirut, Líbano), Socorro De Leon-Mendoza (Kangaroo Mother Care Foundation Philippines, Inc., Filipinas), Ylva Thernström Blomqvist (Hospital Universitario, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Uppsala, Suecia) y Bjorn Westrup (Departamento de Salud de la Mujer y del Niño, Instituto Karolinska, Suecia) por sus revisiones del manuscrito y de los informes breves que ilustran cómo se está practicando el cuidado cariñoso y sensible de recién nacidos pequeños o enfermos en distintos lugares.

Asimismo, damos las gracias a Anne Detjen (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]), Maya Elliott (UNICEF), Leah Greenspan (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID]), Tedbabe Degefie Hailegebriel (UNICEF), Lily Kak (USAID), Romilla Karnati (Momentum Country and Global Leadership/Save the Children), Catherine Kirk (Save the Children), Neena Khadka (Momentum Country and Global Leadership/Save the Children), Jane Lucas (consultora), Silke Mader (European Foundation for the Care of Newborn Infants), Sheila Manji (OMS/MCA), Alison Morgan (Global Financing Facility), Karen New (consultora), Susan Niermeyer (USAID), Ana Nieto (UNICEF) y Theresa Shaver (USAID) por su atenta revisión de las versiones iniciales de este documento breve.

APOYO EDITORIAL:

Peggy Henderson y Sheila Manji

Recursos seleccionados

Every Newborn

Una plataforma de acción conjunta para reducir las muertes neonatales y los mortinatos prevenibles mediante la aplicación del Plan de Acción «Todos los Recién Nacidos», aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2014.

<https://www.healthynewbornnetwork.org/issue/every-newborn/>

Network for Improving the Quality of Care for Maternal, Newborn and Child Health

Una amplia alianza de gobiernos comprometidos, asociados en la ejecución y organismos de financiación que trabaja para que todas las embarazadas, los recién nacidos y los niños reciban atención de buena calidad con equidad y dignidad.

<https://ewene.org/accelerate-maternal-and-newborn-survival/quality-of-care-network/>

Global Alliance for Newborn Care

Una red para mejorar la salud neonatal y materna en el mundo, promover el cuidado cariñoso y sensible en todos los entornos y conseguir que todas las niñas, mujeres y progenitores dispongan de información suficiente para tomar decisiones antes de la concepción y durante el embarazo y el parto, así como durante el seguimiento y la atención continuada tras el alta hospitalaria.

<https://www.glance-network.org/>

Every Premie

Un acuerdo para ofrecer enfoques prácticos que pueden aplicarse de forma amplia y sostenida a fin de ampliar la adopción de intervenciones en los casos de parto prematuro y de bajo peso al nacer en 24 países, principalmente en África y Asia, proporcionando recursos útiles.

<https://www.everypreemie.org/>

Newborn Essential Solutions and Technologies (NEST360)

Una alianza multidisciplinar que trabaja con gobiernos africanos para que todos los hospitales ofrezcan una atención de alta calidad que salve la vida a los recién nacidos pequeños o enfermos. Se trata de un modelo basado en la evidencia para el funcionamiento sostenible de sistemas de salud a escala nacional, lo que incluye resolver las deficiencias relativas a los recursos humanos, la tecnología y los datos.

<https://nest360.org/>

Referencias

1. Survive and thrive: transforming care for every small and sick newborn. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241515887>, consultado el 31 de mayo de 2021).
2. United Nations Interagency Working Group for Child Mortality Estimation. Levels and trends in child mortality. New York: UNICEF; 2020 (<https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/>, consultado el 31 de mayo de 2021).
3. Normas para mejorar la calidad de la atención a los recién nacidos enfermos o de pequeño tamaño en los establecimientos de salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (<https://www.who.int/es/publications/b/54367>, consultado el 31 de mayo de 2021).
4. The Global Health Observatory (<https://www.who.int/data/gho>) and the Maternal, newborn, child and adolescent health and ageing data portal (<https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/global-strategy-data>).
5. Chawanpaiboon S, Vogel JP, Moller A, Lumbiganon P, Petzold M et al. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. *Lancet Glob Health*. 2019;7(7):e37-e46. doi: 10.1016/S2214-109X(18)30451-0.
6. UNICEF, WHO. UNICEF-WHO low birthweight estimates: levels and trends 2000–2015. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.who.int/news/item/07-06-2019-joint-low-birthweight-estimates-levels-and-trends-2000-2015>, consultado el 31 de mayo de 2021).
7. Lawn JE, Davidge R, Paul VK, Von XYlander S, De Graft Johnson J et al. Born too soon: care for the preterm baby. *Reprod Health*. 2013;10(Suppl 1):S5. (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24625233/>, consultado el 31 de mayo de 2021).
8. Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo. Organización Panamericana de la Salud; 2018 (<https://iris.paho.org/handle/10665.2/49550>, consultado el 31 de mayo de 2021).
9. Altimier L, Phillips R. The Neonatal Integrative Developmental Care Model: advanced clinical applications of the seven core measures for neuroprotective family-centered developmental care. *Newborn and Infant Nursing Reviews*. 2016;16(4):230–44.
10. European Standards of Care for Newborn Health. Infant and family-centred developmental care. European Foundation for the Care of Newborn Infants [sitio en internet] (<https://newborn-health-standards.org/standards/standards-english/infant-family-centred-developmental-care/>, consultado el 31 de mayo de 2021).
11. OMS, UNICEF. Guía para la aplicación: proteger, promover y apoyar la lactancia materna en los establecimientos que prestan servicios de maternidad y neonatología: revisión de la iniciativa hospitales amigos del niño. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, UNICEF; 2018 (<https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241513807>, consultado el 31 de mayo de 2021).
12. Gelaye B, Rondon MB, Araya R, Williams MA. Epidemiology of maternal depression, risk factors, and child outcomes in low-income and middle-income countries. *Lancet Psychiatry*. 2016;3(10):973–82.
13. WHO recommendations for postnatal care of the mother and the newborn. Geneva: World Health Organization, 2013 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506649>, consultado el 31 de mayo de 2021).
14. Seale AC, Blencowe H, Manu AA, Nair H, Bahl R et al. Estimates of possible severe bacterial infection in neonates in sub-Saharan Africa, South Asia, and Latin America for 2012: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis*. 2014;14(8):731–41. doi: 10.1016/S1473-3099(14)70804-7.
15. Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural. Iniciativa Hospital Amigo del Niño para recién nacidos pequeños, enfermos y prematuros. Organización Panamericana de la Salud, UNICEF; 2023 (https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57557/9789275327050_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el 31 de mayo de 2021).
16. Conde-Agudelo A, Diaz-Rossello JL. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;(8):CD002771.
17. WHO study group on KMC. Immediate “Kangaroo Mother Care” and the survival of infants with low birth weight. *N Engl J Med*. 2021;384:2028–38. doi: 10.1056/NEJMoa2026486.
18. Klemming S, Lilliesköld S, Westrup B. Mother-newborn couplet care from theory to practice to ensure zero separation for all newborns. *Acta Paediatr*. 2021;00:1–7. doi: 10.1111/apa.15997.
19. Estrategias de recursos humanos destinadas a mejorar la atención neonatal en centros de salud de países de ingresos bajos y medianos. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2021 (<https://www.who.int/es/publications/b/55989>, consultado el 31 de mayo de 2021).
20. Chunling L, Black MM, Richter LM. Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level. *Lancet Glob Health*. 2018;4(12):e916–22. doi:10.1016/S2214-109X(16)30266-2.
21. Heckman JJ. There's more to gain by taking a comprehensive approach to early childhood development. Chicago: The Heckman Equation; 2017 (https://heckmanequation.org/www/assets/2017/01/F_Heckman_CBAOnePager_120516.pdf, consultado el 31 de mayo de 2021).
22. Rollins N, Minckas N, Jehan F, Lodha R, Raiten D et al. A public health approach for deciding policy on infant feeding and mother–infant contact in the context of COVID-19. *Lancet Glob Health*. 2021;9:e552–7. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30538-6.
23. OMS, UNICEF, Grupo del Banco Mundial. El cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo en la primera infancia. Marco para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y prosperar a fin de transformar la salud y el potencial humano. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2021 (<https://iris.paho.org/handle/10665.2/55218>, consultado el 31 de mayo de 2021).

Marco para el cuidado cariñoso y sensible durante la primera infancia

El *Marco del cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo en la primera infancia: un marco para ayudar a los niños a SOBREVIVIR y PROSPERAR a fin de TRANSFORMAR el potencial humano* (23) se basa en las evidencias más recientes sobre el modo en que se produce el desarrollo infantil y sobre las políticas e intervenciones eficaces que pueden mejorar el desarrollo en la primera infancia.

La OMS, el UNICEF y el Grupo del Banco Mundial elaboraron el Marco en colaboración con la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, la Red de Acción para el Desarrollo del Niño en la Primera Infancia y muchos otros asociados a fin de proporcionar una hoja de ruta para alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y los objetivos de sobrevivir, prosperar y transformar de la Estrategia Mundial sobre la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente. Presentado durante la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2018, describe: a) por qué los esfuerzos para mejorar la salud, el bienestar y el capital humano deben empezar en los primeros años de vida, entre el embarazo y los 3 años de edad; b) las principales amenazas para el desarrollo del niño en la primera infancia; c) cómo el cuidado cariñoso y sensible protege a los niños pequeños de los efectos de la adversidad y promueve el desarrollo físico, emocional y cognitivo; y d) lo que las familias y los cuidadores necesitan para proporcionar cuidados cariñosos y sensibles a los niños pequeños.



PARA MÁS INFORMACIÓN

nurturing-care.org
ecdan.org

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

#CuidadoCariñoso
@NurturingCare

CONTACTO

NurturingCare@who.int



Madre e hija conocen al miembro más reciente de la familia en Mongolia.
© UNICEF/UN0198614/Njiokiktjen VII Photo.



Cuidado cariñoso y sensible para todos los recién nacidos: resumen temático [Nurturing care for every newborn: thematic brief]

ISBN (OMS) 978-92-4-011960-4 (versión electrónica)

ISBN (OMS) 978-92-4-011961-1 (versión impresa)

© Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2025.
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)